I. 객관식 30문항 · 5지선다 · 가장 알맞은 것 하나 · 각 2점

1 EBP · EBM 구성요소 기출 2점

EBM에서 통합하는 세 가지 구성요소를 옳게 묶은 것은?

① 최선의 연구 근거 · 임상 전문성 · 환자의 가치와 기대
② 최선의 연구 근거 · 치료 비용 · 환자의 가치와 기대
③ 전문가 의견 · 임상 전문성 · 환자의 가치와 기대
④ 최선의 연구 근거 · 병태생리학적 근거 · 임상적 직관
⑤ 진료 지침 · 치료 비용 · 전문가 의견

2 EBP · EBM의 정의 기출 2점

EBM에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① 캐나다 McMaster 대학의 Sackett 등이 제안하였다.
② 최선의 최신 근거를 개별 환자 진료의 결정에 사용하는 것이다.
③ 외부 근거는 개별 임상 전문성을 결코 대체할 수 없다.
④ 진료 지침을 모든 환자에게 똑같이 적용하는 요리책 의학이다.
⑤ 무작위 대조시험(RCT)과 메타분석에만 국한되지 않는다.

3 EBP · 전통 vs EBP 패러다임 기출 2점

전통 패러다임(traditional paradigm)에 해당하는 것만을 고른 것은?

ㄱ. 일화(anecdote)	ㄴ. 근거의 강도(strength of evidence)	ㄷ. 병태생리학적 근거(pathophysiologic rationale)	ㄹ. 환자의 가치와 선호(patient's values)

① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄹ
④ ㄷ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

4 EBP · EBM의 목적 2점

EBM의 목적으로 옳은 것만을 고른 것은?

ㄱ. 타당하고 여과된 정보를 적용해 생명을 구한다	ㄴ. 시간을 절약한다	ㄷ. 연구 결과로 임상가의 판단을 대체한다	ㄹ. 지식과 기술을 최신으로 유지한다

① ㄱ, ㄴ
② ㄴ, ㄷ
③ ㄱ, ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

5 EBP · 근거의 필요성 2점

졸업 후 햇수와 최신 고혈압 치료 지식 사이의 상관계수가 $R = -0.54$ ($P < 0.001$)였다(slippery slope). 이 결과가 뜻하는 것으로 옳은 것은?

① 졸업 후 햇수가 늘수록 최신 치료 지식이 감소한다.
② 졸업 후 햇수가 늘수록 최신 치료 지식이 증가한다.
③ 두 변수 사이에는 관련이 없다.
④ 결과는 통계적으로 유의하지 않다.
⑤ 임상 경험이 쌓이면 근거를 찾을 필요가 줄어든다.

6 EBP · EBM 5단계 기출 2점

EBM 5단계와 각 단계에서 하는 일의 연결이 옳지 <u>않은</u> 것은?

① Ask — 명확하고 간결하며 임상적인 질문을 만든다
② Acquire — 질문에 답할 최선의 근거를 문헌에서 찾는다
③ Appraise — 근거의 타당성과 적용가능성을 비판적으로 평가한다
④ Evaluate — 근거 논문의 출판 연도와 가격을 평가한다
⑤ Apply — 평가 결과를 임상 전문성·환자 정보와 통합해 적용한다

7 EBP · EBP 과정 그림 2점

EBP 과정 그림(6단계)에서 'Ask clinical questions' 바로 다음 단계는?

① Assess your patients
② Acquire the best evidence
③ Appraise the evidence
④ Apply evidence to patient care
⑤ Evaluate

8 EBP · PICO 사례 기출 2점

"고혈압으로 ACE 억제제를 복용하다 마른기침이 생긴 60세 남성에서, ARB로 바꾸면 ACE 억제제를 계속 쓰는 것보다 기침이 줄어드는가?"를 PICO로 나눈 것으로 옳은 것은?

① P: ARB / I: 60세 남성 / C: 마른기침 / O: ACE 억제제
② P: 60세 남성 / I: ACE 억제제 유지 / C: ARB로 변경 / O: 마른기침 감소
③ P: 60세 남성 / I: ARB로 변경 / C: ACE 억제제 유지 / O: 혈압 측정 횟수
④ P: 고혈압으로 ACE 억제제 복용 중 마른기침이 생긴 60세 남성 / I: ARB로 변경 / C: ACE 억제제 유지 / O: 마른기침 감소
⑤ P: 마른기침 / I: 고혈압 / C: 60세 / O: ARB

9 EBP · PICO 기출 2점

PICO에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① 모든 임상 질문에는 반드시 비교 대상(C)이 있어야 한다.
② P에는 주된 문제와 동반 질환이 들어가며, 때로 성별·나이·인종도 고려한다.
③ I에는 중재뿐 아니라 예후 인자나 노출도 들어갈 수 있다.
④ O는 이루거나 측정하거나 개선하려는 결과이다.
⑤ PICO는 잘 만든 질문의 핵심 요소를 기억하게 돕는 연상 기호이다.

10 EBP · 임상 질문 유형 2점

가장 흔한 임상 질문 유형 4가지에 해당하지 <u>않는</u> 것은?

① 진단 (Diagnosis)
② 치료 (Therapy)
③ 예후 (Prognosis)
④ 위해/병인 (Harm/etiology)
⑤ 비용 (Cost)

11 EBP · 근거 피라미드 순서 기출 2점

근거 수준 피라미드에서 근거 수준이 높은 것부터 순서대로 나열한 것은?

① 체계적 문헌고찰 → RCT → 비평적 분석 주제 → 개별 문헌 비평 → 코호트 → 환자-대조군·증례
② 체계적 문헌고찰 → 비평적 분석 주제 → 개별 문헌 비평 → RCT → 코호트 → 환자-대조군·증례
③ 체계적 문헌고찰 → 비평적 분석 주제 → 개별 문헌 비평 → 코호트 → RCT → 환자-대조군·증례
④ RCT → 체계적 문헌고찰 → 비평적 분석 주제 → 개별 문헌 비평 → 코호트 → 환자-대조군·증례
⑤ 체계적 문헌고찰 → 개별 문헌 비평 → 비평적 분석 주제 → RCT → 코호트 → 환자-대조군·증례

12 EBP · 피라미드 2층 기출 2점

근거 피라미드 2층 '비평적 분석 주제(CAT)'에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 연구 논문 한 편을 전문가가 평가·요약한 것이다.
② 여과되지 않은 정보에 속한다.
③ 하나의 임상 질문(주제)에 대해 여러 연구를 전문가가 비평적으로 평가해 짧게 종합한 요약이다.
④ 참가자를 무작위 배정하는 실험 연구이다.
⑤ 대조군 없이 전문가의 경험만 담은 의견이다.

13 EBP · 여과되지 않은 정보 2점

근거 피라미드에서 여과되지 않은 정보(unfiltered information)에 해당하는 것은?

① 체계적 문헌고찰
② 코호트 연구
③ 비평적 분석 주제(CAT)
④ 개별 문헌에 대한 비평적 분석
⑤ 메타분석

14 EBP · 체계적 문헌고찰 기출 2점

체계적 문헌고찰(systematic review)에 대한 설명으로 옳은 것만을 고른 것은?

ㄱ. 구체적이고 사전에 정해진 포함 기준을 사용한다	ㄴ. 이전 연구들을 모아 요약한 것이다	ㄷ. 저자가 알고 있는 논문만 골라 자유롭게 요약한다	ㄹ. 근거 피라미드의 최상위에 있는 여과된 정보이다

① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

15 EBP · 메타분석 2점

메타분석(meta-analysis)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 여러 연구의 데이터를 통계적으로 결합해 통계적 검정력을 높인다.
② 한 시점에서 집단을 조사하는 관찰 연구이다.
③ 대조군 없이 비슷한 치료를 받은 환자들을 기술한다.
④ 근거 피라미드에서 RCT보다 아래에 있다.
⑤ 결과는 주로 벤 다이어그램으로 나타낸다.

16 EBP · 무작위 대조시험 2점

무작위 대조시험(RCT)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 실험적이고 전향적인 연구이다.
② 참가자를 실험군과 대조군에 무작위로 배정한다.
③ 편향을 막기 위해 눈가림을 사용한다.
④ 치료나 예방 질문에 적합하다.
⑤ 질병이 있는 사람과 없는 사람을 비교해 과거 노출을 조사한다.

17 EBP · 연구 설계 판별 2점

흡연이 폐암의 원인인지 알아보기 위해 폐암 환자 100명과 폐암이 없는 100명을 모아 과거 흡연력을 비교하였다. 이 연구 설계는?

① 무작위 대조시험
② 전향적 코호트 연구
③ 단면 연구
④ 메타분석
⑤ 환자-대조군 연구

18 EBP · 코호트 연구 2점

코호트 연구가 특히 적합한 상황으로 옳은 것은?

① 여러 연구의 결과를 통계적으로 합칠 때
② 노출(예: 흡연)을 무작위 배정하는 것이 비윤리적일 때
③ 한 시점의 유병률만 알고 싶을 때
④ 약 A와 위약을 눈가림하여 배정할 때
⑤ 희귀하고 잠복기가 긴 질병의 원인을 빠르게 찾을 때

19 EBP · 단면 연구 2점

단면 연구(cross-sectional study)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 노출과 결과의 인과관계를 추론할 수 있다.
② 희귀 질환 연구에 가장 적합하다.
③ 한 시점의 데이터로 건강 결과의 유병률을 측정하는 데 자주 쓰인다.
④ 같은 집단을 10년간 추적 관찰한다.
⑤ 연구자가 참가자에게 중재를 배정한다.

20 EBP · 임상 종결점 2점

다음 중 임상 종결점(clinical endpoint)에 해당하는 것은?

① LDL-C 변화율
② 혈압 수치
③ HbA1c 수치
④ 심근경색 발생
⑤ 혈중 약물 농도

21 EBP · 1·2·3차 문헌 기출 2점

문헌의 종류와 예의 연결이 옳은 것은?

① 1차 문헌 — UpToDate
② 2차 문헌 — 원저 논문
③ 3차 문헌 — 종설논문(review article)
④ 2차 문헌 — 교과서
⑤ 1차 문헌 — MEDLINE

22 EBP · 문헌 장단점 기출 2점

1·2·3차 문헌의 특징으로 옳지 않은 것은?

① 1차 문헌은 가장 최신 정보이며 lag time이 가장 짧다.
② 1차 문헌은 저자의 실험만 반영되어 객관적이지 못할 수 있다.
③ 2차 문헌은 1차 문헌의 서지정보를 모아 1차 문헌으로의 직접 접근을 허용한다.
④ 3차 문헌은 lag time이 가장 짧아 최신 정보가 항상 실려 있다.
⑤ 2차 문헌은 사용법이 복잡하고 시스템 구축 비용이 비싸다.

23 EBP · 국내 정보원 2점

낱알만 남은 약의 이름을 확인하려 한다. 슬라이드에서 '의약품 식별 관련 정보량이 많고 정확하다'고 소개한 정보원은?

① 약학정보원
② 식약처 의약품안전나라
③ KIMS 의약품정보센터
④ 건강보험심사평가원
⑤ 한국희귀필수의약품센터

24 EBP · 국외 정보원 2점

UpToDate에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 학술지 원저 논문만 모아 둔 1차 문헌이다.
② 근거 기반·동료 심사를 거친 정보 자료로 웹과 모바일에서 쓸 수 있다.
③ NLM이 운영하는 무료 2차 문헌 DB이다.
④ Harrison's Online을 제공하는 전자 교과서이다.
⑤ 8,000명 이상의 저자가 쓰는 Medscape의 진료 현장 참고자료이다.

25 PubMed · PubMed 개요 기출 2점

PubMed에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 미국 국립보건원(NIH)이 직접 운영하는 유료 데이터베이스이다.
② 1990년 이후의 영어 논문만 수록한다.
③ NLM 산하 NCBI가 운영하며, 수록 논문의 80% 이상은 MEDLINE 등재 학술지에서 온다.
④ 수록된 모든 논문의 원문을 무료로 제공한다.
⑤ MEDLINE이 PubMed를 포함하는 더 큰 데이터베이스이다.

26 PubMed · MeSH 기출 2점

MeSH에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① MeSH 화면의 Entry Terms는 그 용어의 상위 개념 목록이다.
② PubMed 서지정보 색인에 쓰이는 NLM의 통제된 어휘 동의어집이다.
③ 상위/하위 개념을 16개 트리 구조로 분류한다.
④ 1년에 한 번 개정되며 신규 용어가 추가된다.
⑤ MeSH로 검색하면 기본적으로 하위 용어까지 함께 검색된다.

27 PubMed · 자연어 vs MeSH 기출 2점

자연어 검색과 MeSH 검색을 비교한 것으로 옳은 것은?

① 자연어 검색은 정확률(특이도)을 높이는 검색이다.
② MeSH는 저자가 논문에 쓴 키워드를 그대로 모은 것이다.
③ 자연어 검색은 동의어를 빠뜨리지 않는다.
④ PubMed는 MeSH와 자연어를 동시에 검색하지 않는다.
⑤ MeSH 검색은 새로운 개념이나 최신 논문을 누락할 수 있다.

28 PubMed · 자동 용어 매핑 2점

검색창에 pharmacy student를 입력하였다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

① Author → Journal → MeSH 순서로 매핑된다.
② 두 단어 사이의 공백은 OR로 처리된다.
③ 변환된 검색식은 Advanced → Details에서 확인할 수 있다.
④ MeSH 검색만 이루어지고 All Fields 검색은 하지 않는다.
⑤ 큰따옴표로 감싸도 자동 매핑은 그대로 작동한다.

29 PubMed · 필드 태그 기출 2점

필드 태그를 사용한 검색식 중 형식이 옳지 <u>않은</u> 것은?

① aspirin[mh] OR aspirin[tiab]
② aspirin[ti] AND 2015:2020[dp]
③ statin*[tiab] NOT letter[pt]
④ diabetes[majr]
⑤ (aspirin OR ibuprofen)[ti]

30 PubMed · 검색 기술 구별 기출 2점

검색 기술에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 인접검색에서 N이 커질수록 검색 결과 수는 줄어든다.
② 어구검색(" ")을 하면 검색 결과 수가 늘어난다.
③ "drug interaction"[tiab:~3]은 두 단어 사이에 3개 이하의 단어가 있어도 검색하며, 단어 순서는 상관없다.
④ 절단검색(*)은 * 앞에 최소 2글자만 있으면 된다.
⑤ 괄호가 없으면 오른쪽에서 왼쪽으로 계산된다.

II. 단답형 6문항 · 칸 안에 답을 쓰시오 · 각 4점

31 EBP · Sackett 정의 기출 4점

다음은 Sackett의 EBM 정의이다. 빈칸에 알맞은 말을 쓰시오.

" ① _____ 근거를 ② _____ 환자의 진료에 대한 ③ _____ 을(를) 내리는 데 성실하고, 명시적이며, 신중하게 사용하는 것"

32 EBP · 근거 피라미드 기출 4점

근거 수준 피라미드의 빈칸에 알맞은 말을 쓰시오.

1층 체계적 문헌고찰 → 2층 ① _____ → 3층 ② _____ →

4층 RCT → 5층 코호트 연구 → 6층 환자-대조군 연구·증례 보고 → 7층 기본 배경 정보 / 전문가 의견

1–3층은 ③ _____ 정보이다.

33 PubMed · PubMed 운영 기출 4점

빈칸에 알맞은 말을 쓰시오.

PubMed는 미국 국립의학도서관 ① _____ 산하 ② _____

가 운영하는 무료 데이터베이스이며, 수록 논문의 80% 이상은 ③ _____ 등재 학술지

에서 온다.

34 PubMed · 인접검색 검색식 4점

제목(title)에 pharmacy와 education이 두 단어 사이에 2개 이하의 단어를 두고(순서 무관) 나타나는 논문을 찾는 검색식을 쓰시오.

검색식: ① _____

35 EBP · 1·2·3차 문헌 기출 4점

다음에 해당하는 문헌의 종류를 쓰시오.

(1) lag time이 가장 긴 문헌: ① _____

(2) 1차 문헌의 서지정보를 모아 데이터베이스로 정리한 문헌과 그 대표 예 1가지:

② _____

36 EBP · EBM 5단계 4점

EBM 5단계 중 근거의 타당성(validity)과 적용가능성(applicability)을 비판적으로 평가하는 단계와, 그 바로 앞 단계의 이름을 영어로 쓰시오.

평가 단계: ① _____ · 바로 앞 단계: ② _____

III. 서술형 4문항 · 짧게, 그러나 핵심어는 빠짐없이 · 각 4점

37 EBP · EBM 5단계 기출 4점

EBM 5단계를 순서대로 쓰고, 각 단계에서 하는 일을 한 문장씩 설명하시오.

답안

38 EBP · PICO 질문 만들기 기출 4점

다음 사례를 PICO로 나누고, 한 문장의 임상 질문으로 쓰시오.

비판막성 심방세동으로 와파린을 복용 중인 75세 여성이, 아픽사반으로 바꾸면 출혈 위험이 줄어드는지 묻는다.

답안

39 EBP · 피라미드 2층·3층 기출 4점

근거 피라미드의 2층과 3층을 각각 설명하고, 여과된 정보와 여과되지 않은 정보의 차이를 쓰시오.

답안

40 PubMed · 자연어 vs MeSH 기출 4점

자연어 검색과 MeSH 검색의 장단점을 비교하고, 실제 검색에서 둘을 어떻게 함께 쓰는지 예를 들어 쓰시오.

답안

정답 **빠른 정답표 · 채점 후 틀린 번호만 해설로!**

객관식 정답 분포 ① 6개 · ② 6개 · ③ 6개 · ④ 6개 · ⑤ 6개

I. 객관식 (1–30) · 각 2점

1 ① EBM 구성요소	2 ④ EBM의 정의	3 ② 전통 vs EBP 패러다임	4 ④ EBM의 목적	5 ① 근거의 필요성	6 ④ EBM 5단계	7 ② EBP 과정 그림	8 ④ PICO 사례	9 ① PICO	10 ⑤ 임상 질문 유형
11 ② 근거 피라미드 순서	12 ③ 피라미드 2층	13 ② 여과되지 않은 정보	14 ⑤ 체계적 문헌고찰	15 ① 메타분석	16 ⑤ 무작위 대조시험	17 ⑤ 연구 설계 판별	18 ② 코호트 연구	19 ③ 단면 연구	20 ④ 임상 종결점
21 ③ 1·2·3차 문헌	22 ④ 문헌 장단점	23 ① 국내 정보원	24 ② 국외 정보원	25 ③ PubMed 개요	26 ① MeSH	27 ⑤ 자연어 vs MeSH	28 ③ 자동 용어 매핑	29 ⑤ 필드 태그	30 ③ 검색 기술 구별

II. 단답형 (31–36) · 각 4점

31 ① current best (최선의 최신) ② individual (개별) ③ decisions (결정)

32 ① 비평적 [즉, 장단점을 따져 믿을 만한지 평가하는] 분석 주제 (Critically-Appraised Topics, CAT (Critically-Appraised Topic, 비평적 분석 주제: 한 질문에 대한 여러 연구의 평가 요약)) ② 개별 문헌에 대한 비평적 분석 (Critically-Appraised Individual Articles) ③ 여과된 (filtered)

33 ① NLM (National Library of Medicine) ② NCBI (National Center for Biotechnology Information) ③ MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, 메드라인: NLM이 선별한 학술지의 서지 DB)

34 ① "pharmacy education"[ti:~2] (또는 [title:~2])

35 ① 3차 문헌 ② 2차 문헌 — PubMed (또는 MEDLINE, EMBASE (Excerpta Medica Database, 엠베이스: 유럽 중심의 의약학 서지 DB))

36 ① Appraise (비판적 평가) ② Acquire (근거 찾기)

III. 서술형 (37–40) · 각 4점 — 핵심어

37	EBM (Evidence-Based Medicine, 근거중심의학: 연구 근거를 바탕으로 진료를 결정하는 방식) 5단계	Ask (질문하다) · 3C · PICO (Patient·Intervention·Comparison·Outcome, 환자·중재·비교·결과: 임상 질문을 만드는 4요소) · Acquire · 문헌 검색 · Appraise · 타당성·적용가능성 · Apply (적용) · 전문성+환자 · Evaluate (평가·개선) · 효과성·효율성
38	PICO 질문 만들기	P 환자·질환·나이 · I 새 중재 [즉, 환자에게 하는 치료·처치](아픽사반) · C 비교(와파린) · O 측정 가능한 결과(출혈) · 한 문장 질문
39	피라미드 2층·3층	2층 CAT · 주제 · 여러 연구 종합 · 3층 · 논문 1편 평가 · 여과 = 이미 평가·종합 · 비여과 = 원 연구 · 직접 평가
40	자연어 vs MeSH (Medical Subject Headings, 메쉬: 의학 주제 표목 — 논문 분류용 표준 주제어)	자연어 = 재현율 [즉, 관련 논문을 빠뜨리지 않고 찾아내는 비율](민감도 [즉, 있는 것을 있다고 잡아내는 능력])↑ · 자연어 단점 = 동의어 누락 · MeSH = 정확률 [즉, 찾은 논문 중 진짜 관련 있는 논문의 비율](특이도 [즉, 없는 것을 없다고 걸러내는 능력])↑ · MeSH 단점 = 새 개념·최신 논문 누락 · MeSH OR 자연어 예

🎯 기출 매칭 **선배 족보·중간 복기에 나온 주제를 다시 낸 문항: 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40번 (24문항). 이 번호를 틀렸다면 마스터 노트의 「기출 복기」 문항부터 다시.**

📊 점수 읽기 **90점 이상: 실전 준비 완료 · 75–89점: 틀린 주제만 마스터 노트 해당 PART 다시 · 74점 이하: 마스터 노트 요약 페이지부터 복습**

문제 01 EBP · EBM 구성요소 기출

EBM에서 통합하는 세 가지 구성요소를 옳게 묶은 것은?

① 최선의 연구 근거 · 임상 전문성 · 환자의 가치와 기대
② 최선의 연구 근거 · 치료 비용 · 환자의 가치와 기대
③ 전문가 의견 · 임상 전문성 · 환자의 가치와 기대
④ 최선의 연구 근거 · 병태생리학적 근거 · 임상적 직관
⑤ 진료 지침 · 치료 비용 · 전문가 의견

✏️ 내 풀이

정답 ① 최선의 연구 근거 · 임상 전문성 · 환자의 가치와 기대

🧭 **사고의 흐름**

💡 연결 벤 다이어그램: Best External Evidence · Individual Clinical Expertise · Patient Values & Expectations → 세 원의 교집합 = EBM

☑️ **보기별 체크**

① ○ Slide 11 벤 다이어그램의 세 원 그대로.
② ✕ 비용은 구성요소가 아님 — "EBM (Evidence-Based Medicine, 근거중심의학: 연구 근거를 바탕으로 진료를 결정하는 방식)은 비용 절감 의학이 아니다".
③ ✕ 전문가 의견은 **전통 패러다임**의 근거이자 피라미드 맨 아래.
④ ✕ 병태생리 [즉, 병이 몸 안에서 일어나는 원리]·직관 [즉, 근거 없이 감으로 아는 것] 모두 **전통 패러다임** 쪽 단어.
⑤ ✕ 지침을 기계적으로 따르는 것은 요리책 의학 — EBM이 아님.

🧠 한 줄 **근거 + 전문성 + 환자 = EBM**

문제 02 EBP · EBM의 정의 기출

EBM에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 캐나다 McMaster 대학의 Sackett 등이 제안하였다.
② 최선의 최신 근거를 개별 환자 진료의 결정에 사용하는 것이다.
③ 외부 근거는 개별 임상 전문성을 결코 대체할 수 없다.
④ 진료 지침을 모든 환자에게 똑같이 적용하는 요리책 의학이다.
⑤ 무작위 대조시험(RCT)과 메타분석에만 국한되지 않는다.

✏️ 내 풀이

정답 ④ 진료 지침을 모든 환자에게 똑같이 적용하는 요리책 의학이다.

🧭 **사고의 흐름**

👀 단서 "옳지 않은 것" → What EBM is NOT 4가지(요리책 · 대체 · 비용 절감 · RCT만)를 뒤집은 문장을 찾기

☑️ **보기별 체크**

① ✕ Slide 8 a 그대로 — 맞는 설명.
② ✕ Sackett(1996) 정의 — 맞는 설명.
③ ✕ What EBM is NOT b — 맞는 설명.
④ ○ What EBM is NOT a — EBM은 요리책 의학이 **아님**. 환자 상황에 맞게 판단.
⑤ ✕ What EBM is NOT d — 맞는 설명.

🧠 한 줄 **EBM은 요리책·대체·비용절감·RCT** (Randomized Controlled Trial, 무작위 대조시험: 제비뽑기로 군을 나눠 비교하는 실험 연구) **전용이 아니다**

문제 03 EBP · 전통 vs EBP 패러다임 기출

전통 패러다임(traditional paradigm)에 해당하는 것만을 고른 것은?

ㄱ. 일화 (anecdote)	ㄴ. 근거의 강도(strength of evidence)	ㄷ. 병태생리학적 근거 (pathophysiologic rationale)	ㄹ. 환자의 가치와 선호 (patient's values)

① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄹ
④ ㄷ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

✏️ 내 풀이

정답 ② ㄱ, ㄷ

🧭 **사고의 흐름**

💡 연결 전통 = 비체계적 경험(일화·도제식 수련·전문가 의견) · 병태생리 · 임상적 직관 · 가능한 이익

💡 연결 EBP = 근거의 강도 · 이익/위험의 정량적 서술 · 환자의 가치 · 정보에 근거한 의사결정

☑️ **보기별 체크**

① ✕ ㄴ 근거의 강도는 **EBP** (Evidence-Based Pharmacotherapy/Practice, 근거중심 약물치료·실무: 약사·간호 등 실무로 넓힌 EBM) 패러다임.

② ○ ㄱ 일화 [즉, "이랬더니 좋더라" 하는 개인 경험담] = 비체계적 경험, ㄷ 병태생리 [즉, 병이 몸 안에서 일어나는 원리] = 전통.

③ ✕ 둘 다 **EBP** 패러다임 — 정반대.

④ ✕ ㄹ 환자의 가치는 **EBP** 패러다임.

⑤ ✕ ㄹ이 섞여 있어 오답.

🧠 **한 줄** **전통 = 경험·원리·직관** [즉, 근거 없이 감으로 아는 것] **/ EBP = 강도·숫자·환자**

문제 04 EBP · EBM의 목적

EBM의 목적으로 옳은 것만을 고른 것은?

ㄱ. 타당하고 여과된 정보를 적용해 생명을 구한다	ㄴ. 시간을 절약한다	ㄷ. 연구 결과로 임상가의 판단을 대체한다	ㄹ. 지식과 기술을 최신으로 유지한다

① ㄱ, ㄴ
② ㄴ, ㄷ
③ ㄱ, ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

✏️ 내 풀이

정답 ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ

🧭 **사고의 흐름**

🔍 함정 체크 ㄷ ✕ 목적 d는 임상 판단을 **보완** — 대체가 아님 (What EBM is NOT b와도 연결)

☑️ **보기별 체크**

① ✕ ㄹ이 빠짐.

② ✕ ㄷ은 틀린 문장, ㄱ·ㄹ이 빠짐.

③ ✕ ㄷ이 섞임.

④ ○ 목적 a·b·c 그대로.

⑤ ✕ ㄷ이 섞임.

🧠 **한 줄** **생명 · 시간 · 최신 유지 · 판단 보완**

문제 05 EBP · 근거의 필요성

졸업 후 햇수와 최신 고혈압 치료 지식 사이의 상관계수가 R = −0.54 (P < 0.001)였다(slippery slope). 이 결과가 뜻하는 것으로 옳은 것은?

① 졸업 후 햇수가 늘수록 최신 치료 지식이 감소한다.
② 졸업 후 햇수가 늘수록 최신 치료 지식이 증가한다.
③ 두 변수 사이에는 관련이 없다.
④ 결과는 통계적으로 유의하지 않다.
⑤ 임상 경험이 쌓이면 근거를 찾을 필요가 줄어든다.

✏️ 내 풀이

정답 ① 졸업 후 햇수가 늘수록 최신 치료 지식이 감소한다.

🧭 **사고의 흐름**

👀 단서 R의 부호(−) = 방향, P < 0.05 = 유의

☑️ **보기별 체크**

① ○ R이 음수 = 음의 상관, P < 0.001 = 유의.
② ✕ 양의 상관일 때의 해석 — R의 부호가 반대.
③ ✕ R = −0.54는 중간 크기의 상관.
④ ✕ P < 0.001 → 유의함.
⑤ ✕ 오히려 지식이 낡으므로 근거를 **계속** 찾아야 함 (EBM의 필요성).

🧠 한 줄 **공부를 멈추면 미끄러진다**

문제 06 EBP · EBM 5단계 기출

EBM 5단계와 각 단계에서 하는 일의 연결이 옳지 <u>않은</u> 것은?

① Ask — 명확하고 간결하며 임상적인 질문을 만든다
② Acquire — 질문에 답할 최선의 근거를 문헌에서 찾는다
③ Appraise — 근거의 타당성과 적용가능성을 비판적으로 평가한다
④ Evaluate — 근거 논문의 출판 연도와 가격을 평가한다
⑤ Apply — 평가 결과를 임상 전문성·환자 정보와 통합해 적용한다

✏️ 내 풀이

정답 ④ Evaluate — 근거 논문의 출판 연도와 가격을 평가한다

🧭 **사고의 흐름**

💡 연결 Ask → Acquire → Appraise → Apply → Evaluate (Sackett DL et al, 2000)

☑️ **보기별 체크**

① ✕ 3C — 맞음.
② ✕ 문헌 검색 — 맞음.
③ ✕ validity + applicability — 맞음.
④ ○ Evaluate = 1–4단계 수행의 **효과성·효율성** 평가 → 다음번 개선.
⑤ ✕ 맞음.

🧠 한 줄 **질문 → 찾기 → 평가 → 적용 → 되돌아보기**

문제 07 EBP · EBP 과정 그림

EBP 과정 그림(6단계)에서 'Ask clinical questions' 바로 다음 단계는?

① Assess your patients
② Acquire the best evidence
③ Appraise the evidence
④ Apply evidence to patient care
⑤ Evaluate

✏️ 내 풀이

정답 ② Acquire the best evidence

🧭 **사고의 흐름**

💡 연결 Assess → Ask → Acquire → Appraise → Apply → Evaluate

☑️ **보기별 체크**

① ✕ 그림의 **첫** 상자 — Ask보다 앞.
② ○ 질문 다음에 근거를 찾음.
③ ✕ Acquire 다음 단계.
④ ✕ Appraise 다음 단계.
⑤ ✕ 마지막 단계.

🧠 한 줄 **A-A-A-A-A-E**

문제 08 EBP · PICO 사례 기출

"고혈압으로 ACE 억제제를 복용하다 마른기침이 생긴 60세 남성에서, ARB로 바꾸면 ACE 억제제를 계속 쓰는 것보다 기침이 줄어드는가?"를 PICO로 나눈 것으로 옳은 것은?

① P: ARB / I: 60세 남성 / C: 마른기침 / O: ACE 억제제
② P: 60세 남성 / I: ACE 억제제 유지 / C: ARB로 변경 / O: 마른기침 감소
③ P: 60세 남성 / I: ARB로 변경 / C: ACE 억제제 유지 / O: 혈압 측정 횟수
④ P: 고혈압으로 ACE 억제제 복용 중 마른기침이 생긴 60세 남성 / I: ARB로 변경 / C: ACE 억제제 유지 / O: 마른기침 감소
⑤ P: 마른기침 / I: 고혈압 / C: 60세 / O: ARB

✏️ 내 풀이

정답 ④ **P: 고혈압으로 ACE** (Angiotensin-Converting Enzyme, 안지오텐신 전환효소: 이것을 막는 약이 혈압약) **억제제 복용 중 마른기침이 생긴 60세 남성 / I: ARB** (Angiotensin II Receptor Blocker, 안지오텐신 수용체 차단제: 혈압·심부전 약)**로 변경 / C: ACE 억제제 유지 / O: 마른기침 감소**

🧭 **사고의 흐름**

👀 단서 "~에서(P), ~하면(I) ~보다(C) ~가 줄어드는가(O)?" 문장 틀에 맞춰 자르기

☑️ **보기별 체크**

① ✗ 요소가 뒤죽박죽 — P는 **환자**, I·C는 **약**, O는 **결과**.
② ✗ I와 C가 뒤바뀜 — 새로 고려하는 중재 [즉, 환자에게 하는 치료·처치](ARB)가 I.
③ ✗ O는 질문이 개선하려는 결과(**기침**).
④ ○ 네 요소가 모두 제자리.
⑤ ✗ 증상·질병·나이·약을 엉뚱한 칸에 넣음.

🧠 한 줄 **P 환자 · I 새 중재 · C 비교 · O 결과**

문제 09 EBP · PICO 기출

PICO에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① 모든 임상 질문에는 반드시 비교 대상(C)이 있어야 한다.
② P에는 주된 문제와 동반 질환이 들어가며, 때로 성별·나이·인종도 고려한다.
③ I에는 중재뿐 아니라 예후 인자나 노출도 들어갈 수 있다.
④ O는 이루거나 측정하거나 개선하려는 결과이다.
⑤ PICO는 잘 만든 질문의 핵심 요소를 기억하게 돕는 연상 기호이다.

✏️ 내 풀이

정답 ① **모든 임상 질문에는 반드시 비교 대상(C)이 있어야 한다.**

🧭 **사고의 흐름**

🔍 함정 체크 "반드시 · 항상 · 모든"이 들어간 보기를 먼저 의심

☑️ **보기별 체크**

① ○ "임상 질문에 **항상** 특정 비교 대상이 필요한 것은 아니다" (Slide 20).
② ✗ Slide 19 — 맞음.
③ ✗ Intervention, prognostic factor, or exposure — 맞음.
④ ✗ 맞음.
⑤ ✗ mnemonic (연상 기호) — 맞음.

🧠 한 줄 **C는 생략 가능**

문제 10 EBP · 임상 질문 유형

가장 흔한 임상 질문 유형 4가지에 해당하지 않는 것은?

① 진단 (Diagnosis)
② 치료 (Therapy)
③ 예후 (Prognosis)
④ 위해/병인 (Harm/etiology)
⑤ 비용 (Cost)

✏️ 내 풀이

정답 ⑤ 비용 (Cost)

🧭 **사고의 흐름**

💡 연결 진단 → 단면 / 치료 → RCT / 예후 → 코호트 / 위해·병인 → 코호트·환자-대조군

☑️ **보기별 체크**

① ✕ 4유형 a.
② ✕ 4유형 b.
③ ✕ 4유형 c.
④ ✕ 4유형 d.
⑤ ○ 슬라이드의 4유형에 없음.

🧠 한 줄 **진·치·예·위**

문제 11 EBP · 근거 피라미드 순서 기출

근거 수준 피라미드에서 근거 수준이 높은 것부터 순서대로 나열한 것은?

① 체계적 문헌고찰 → RCT → 비평적 분석 주제 → 개별 문헌 비평 → 코호트 → 환자-대조군·증례
② 체계적 문헌고찰 → 비평적 분석 주제 → 개별 문헌 비평 → RCT → 코호트 → 환자-대조군·증례
③ 체계적 문헌고찰 → 비평적 분석 주제 → 개별 문헌 비평 → 코호트 → RCT → 환자-대조군·증례
④ RCT → 체계적 문헌고찰 → 비평적 분석 주제 → 개별 문헌 비평 → 코호트 → 환자-대조군·증례
⑤ 체계적 문헌고찰 → 개별 문헌 비평 → 비평적 분석 주제 → RCT → 코호트 → 환자-대조군·증례

✏️ 내 풀이

정답 ② **체계적 문헌고찰 → 비평적** [즉, 장단점을 따져 믿을 만한지 평가하는] **분석 주제 → 개별 문헌 비평 → RCT** (Randomized Controlled Trial, 무작위 대조시험: 제비뽑기로 군을 나눠 비교하는 실험 연구) **→ 코호트 → 환자-대조군·증례**

🧭 **사고의 흐름**

💡 연결 1–3층 여과된 정보 → 4–6층 원 연구 → 7층 배경 정보·전문가 의견

☑️ **보기별 체크**

① ✕ 여과된 정보(2·3층)가 RCT보다 **위**.
② ○ 그림 27-1 위에서부터 그대로.
③ ✕ RCT가 코호트보다 **위**.
④ ✕ 체계적 문헌고찰이 **최상위**.
⑤ ✕ 주제(여러 연구 종합)가 논문 1편보다 **위**.

🧠 한 줄 **SR** (Systematic Review, 체계적 문헌고찰: 정해진 기준으로 관련 연구를 모두 모아 평가·요약) **· CAT** (Critically-Appraised Topic, 비평적 분석 주제: 한 질문에 대한 여러 연구의 평가 요약) **· 1편 · RCT · 코호트 · 환대·증례 · 의견**

문제 12 EBP · 피라미드 2층 기출

근거 피라미드 2층 '비평적 분석 주제(CAT)'에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 연구 논문 한 편을 전문가가 평가·요약한 것이다.
② 여과되지 않은 정보에 속한다.
③ 하나의 임상 질문(주제)에 대해 여러 연구를 전문가가 비평적으로 평가해 짧게 종합한 요약이다.
④ 참가자를 무작위 배정하는 실험 연구이다.
⑤ 대조군 없이 전문가의 경험만 담은 의견이다.

✏️ 내 풀이

정답 ③ 하나의 임상 질문(주제)에 대해 여러 연구를 전문가가 비평적으로 [즉, 장단점을 따져 믿을 만한지 평가하는] **평가해 짧게 종합한 요약이다.**

🧭 **사고의 흐름**

💡 연결 2층 = 주제(Topic) · 여러 연구 / 3층 = 논문(Article) 1편

☑️ **보기별 체크**

① ✕ 이건 **3층** 개별 문헌에 대한 비평적 분석.
② ✕ 1–3층은 **여과된** 정보.
③ ○ Critically-Appraised **Topics** — 주제 단위·여러 연구.
④ ✕ 이건 4층 **RCT** (Randomized Controlled Trial, 무작위 대조시험: 제비뽑기로 군을 나눠 비교하는 실험 연구).
⑤ ✕ 이건 7층 **전문가 의견**.

🧠 한 줄 **CAT** (Critically-Appraised Topic, 비평적 분석 주제: 한 질문에 대한 여러 연구의 평가 요약) **= 한 질문, 여러 연구, 짧은 종합**

문제 13 EBP · 여과되지 않은 정보

근거 피라미드에서 여과되지 않은 정보(unfiltered information)에 해당하는 것은?

① 체계적 문헌고찰
② 코호트 연구
③ 비평적 분석 주제(CAT)
④ 개별 문헌에 대한 비평적 분석
⑤ 메타분석

✏️ 내 풀이

정답 ② 코호트 연구

🧭 **사고의 흐름**

💡 연결 여과 = 누가 이미 평가·종합했나? 원 연구(RCT·코호트·환자-대조군·증례)는 아직 아무도 안 거름

☑️ **보기별 체크**

① ✕ 1층 — 여과된 정보.
② ○ 5층 원 연구 — 직접 평가해야 하는 여과되지 않은 정보.
③ ✕ 2층 — 여과된 정보.
④ ✕ 3층 — 여과된 정보.
⑤ ✕ 체계적 문헌고찰과 함께 최상위 — 여과된 정보.

🧠 한 줄 **원 연구 = 비여과**

문제 14 EBP · 체계적 문헌고찰 기출

체계적 문헌고찰(systematic review)에 대한 설명으로 옳은 것만을 고른 것은?

ㄱ. 구체적이고 사전에 정해진 포함 기준을 사용한다	ㄴ. 이전 연구들을 모아 요약한 것이다	ㄷ. 저자가 알고 있는 논문만 골라 자유롭게 요약한다	ㄹ. 근거 피라미드의 최상위에 있는 여과된 정보이다

① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

✏️ 내 풀이

정답 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

🧭 **사고의 흐름**

🔍 함정 체크 ㄷ ✕ 저자 임의 선택은 **서술적 종설(narrative review)** — 체계적 문헌고찰은 검색·선정이 재현 가능

☑️ **보기별 체크**

① ✕ ㄹ이 빠짐.
② ✕ ㄷ이 섞임.
③ ✕ ㄷ이 섞임.
④ ✕ ㄷ이 섞임.
⑤ ○ Slide 24 a·b + 피라미드 1층.

🧠 한 줄 **사전 기준 · 모아 요약 · 최상위**

문제 15 EBP · 메타분석

메타분석(meta-analysis)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 여러 연구의 데이터를 통계적으로 결합해 통계적 검정력을 높인다.
② 한 시점에서 집단을 조사하는 관찰 연구이다.
③ 대조군 없이 비슷한 치료를 받은 환자들을 기술한다.
④ 근거 피라미드에서 RCT보다 아래에 있다.
⑤ 결과는 주로 벤 다이어그램으로 나타낸다.

✏️ 내 풀이

정답 ① **여러 연구의 데이터를 통계적으로 결합해 통계적 검정력을** [즉, 진짜 효과가 있을 때 그것을 잡아낼 확률] **높인다.**

🧭 **사고의 흐름**

💡 연결 체계적 문헌고찰로 모은 연구를 숫자로 합치면 메타분석

☑️ **보기별 체크**

① ○ increase (statistical power (통계적 검정력) [즉, 진짜 효과가 있을 때 그것을 잡아낼 확률]) — Slide 25 c.
② ✕ 이건 **단면 연구**.
③ ✕ 이건 **증례 연구**.
④ ✕ "Best evidence" — **최상위**.
⑤ ✕ **forest plot** (포레스트 플롯) [즉, 연구별 효과를 가로선으로 모아 그린 숲 모양 그림](포레스트 플롯)으로 나타냄.

🧠 한 줄 **합치면 검정력 ↑**

문제 16 EBP · 무작위 대조시험

무작위 대조시험(RCT)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 실험적이고 전향적인 연구이다.
② 참가자를 실험군과 대조군에 무작위로 배정한다.
③ 편향을 막기 위해 눈가림을 사용한다.
④ 치료나 예방 질문에 적합하다.
⑤ 질병이 있는 사람과 없는 사람을 비교해 과거 노출을 조사한다.

✏️ 내 풀이

정답 ⑤ 질병이 있는 사람과 없는 사람을 비교해 과거 노출을 조사한다.

🧭 **사고의 흐름**

👀 단서 "과거 · 질병 유무로 시작" = 환자-대조군의 신호어

☑️ **보기별 체크**

① ✕ Slide 26 a — 맞음.
② ✕ b — 맞음.
③ ✕ c — 맞음.
④ ✕ d — 맞음.
⑤ ○ 이건 **환자-대조군 연구**(후향적 [즉, 이미 일어난 과거를 거슬러 조사하는]·관찰적 [즉, 연구자가 개입하지 않고 지켜보기만 하는]).

🧠 한 줄 **RCT** (Randomized Controlled Trial, 무작위 대조시험: 제비뽑기로 군을 나눠 비교하는 실험 연구) **= 실험 · 전향 · 무작위** [즉, 제비뽑기처럼 우연에 맡겨] **· 눈가림** [즉, 누가 진짜 약을 받는지 모르게 가리는 것]

문제 17 EBP · 연구 설계 판별

흡연이 폐암의 원인인지 알아보기 위해 폐암 환자 100명과 폐암이 없는 100명을 모아 과거 흡연력을 비교하였다. 이 연구 설계는?

① 무작위 대조시험
② 전향적 코호트 연구
③ 단면 연구
④ 메타분석
⑤ 환자-대조군 연구

✏️ 내 풀이

정답 ⑤ 환자-대조군 연구

🧭 **사고의 흐름**

👀 단서 출발점이 질병(폐암 O/X) → 시간 방향이 과거 → 환자-대조군

☑️ **보기별 체크**

① ✕ 흡연을 무작위 배정할 수 없음(비윤리적) + 배정 과정이 없음.
② ✕ 코호트는 **노출**에서 출발해 앞으로 추적.
③ ✕ 한 시점의 노출·결과를 동시에 측정 — 과거를 거슬러 가지 않음.
④ ✕ 여러 연구를 합친 것이 아님.
⑤ ○ **질병 유무**로 출발해 **과거 노출**을 조사.

🧠 한 줄 **질병에서 출발 = 환자-대조군**

문제 18 EBP · 코호트 연구

코호트 연구가 특히 적합한 상황으로 옳은 것은?

① 여러 연구의 결과를 통계적으로 합칠 때
② 노출(예: 흡연)을 무작위 배정하는 것이 비윤리적일 때
③ 한 시점의 유병률만 알고 싶을 때
④ 약 A와 위약을 눈가림하여 배정할 때
⑤ 희귀하고 잠복기가 긴 질병의 원인을 빠르게 찾을 때

✏️ 내 풀이

정답 ② 노출(예: 흡연)을 무작위 [즉, 제비뽑기처럼 우연에 맡겨] 배정하는 것이 비윤리적일 때

🧭 **사고의 흐름**

💡 연결 코호트 = 집단을 추적(followed), 통제되지 않은 조건 → RCT보다 덜 신뢰, 대신 윤리 문제 해결

☑️ **보기별 체크**

① ✕ **메타분석**.
② ○ Slide 27 d — RCT (Randomized Controlled Trial, 무작위 대조시험: 제비뽑기로 군을 나눠 비교하는 실험 연구)가 비윤리적일 때 좋음.
③ ✕ **단면 연구**.
④ ✕ **RCT**.
⑤ ✕ **환자-대조군**이 더 적합 (Slide 28 d).

🧠 한 줄 **RCT가 비윤리적이면 코호트**

문제 19 EBP · 단면 연구

단면 연구(cross-sectional study)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 노출과 결과의 인과관계를 추론할 수 있다.
② 희귀 질환 연구에 가장 적합하다.
③ 한 시점의 데이터로 건강 결과의 유병률을 측정하는 데 자주 쓰인다.
④ 같은 집단을 10년간 추적 관찰한다.
⑤ 연구자가 참가자에게 중재를 배정한다.

✏️ 내 풀이

정답 ③ 한 시점의 데이터로 건강 결과의 유병률을 [즉, 특정 시점에 그 병을 가진 사람의 비율] 측정하는 데 자주 쓰인다.

🧭 **사고의 흐름**

💡 연결 단면 = 한 장의 사진 → 유병률 O / 인과 X

☑️ **보기별 체크**

① ✕ 동시에 측정 → 선후를 모름 → 인과 [즉, 하나가 다른 하나의 원인이 되는 관계] **불가**.
② ✕ Slide 29 c — 희귀 질환 연구 **불가**.
③ ○ Slide 29 a·b.
④ ✕ **코호트**.
⑤ ✕ **RCT**.

🧠 한 줄 **한 시점 · 유병률 · 인과 ×**

문제 20 EBP · 임상 종결점

다음 중 임상 종결점(clinical endpoint)에 해당하는 것은?

① LDL-C 변화율
② 혈압 수치
③ HbA1c 수치
④ 심근경색 발생
⑤ 혈중 약물 농도

✏️ 내 풀이

정답 ④ 심근경색 발생

🧭 **사고의 흐름**

👀 단서 "환자가 직접 겪는 사건인가, 검사지에 찍히는 숫자인가?"

☑️ **보기별 체크**

① ✕ Slide 26 f — **대리 표지자** [즉, 진짜 결과 대신 빨리 잴 수 있는 검사 수치].
② ✕ 검사 수치 → 대리 표지자.
③ ✕ 혈당 검사 수치 → 대리 표지자.
④ ○ Slide 26 e 예 (MI, 사망) — 환자에게 직접 의미.
⑤ ✕ 환자가 직접 겪는 결과가 아닌 검사 수치.

🧠 한 줄 **사건 = 종결점 / 숫자 = 대리**

문제 21 EBP · 1·2·3차 문헌 기출

문헌의 종류와 예의 연결이 옳은 것은?

① 1차 문헌 — UpToDate
② 2차 문헌 — 원저 논문
③ 3차 문헌 — 종설논문(review article)
④ 2차 문헌 — 교과서
⑤ 1차 문헌 — MEDLINE

✏️ 내 풀이

정답 ③ 3차 문헌 — 종설논문 [즉, 여러 논문을 모아 정리한 리뷰 논문]**(review article)**

🧭 **사고의 흐름**

💡 연결 1차 = 원자료(원저·증례) / 2차 = 서지정보 DB(PubMed·MEDLINE) / 3차 = 종합(교과서·의약품집·종설·UpToDate)

🔍 함정 체크 🎙️ 교수님: 1·2·3차 문헌은 중간고사에 나온다

☑️ **보기별 체크**

① ✕ UpToDate (업투데이트)는 **3차** 전문 DB (DataBase, 데이터베이스: 자료를 모아 검색할 수 있게 정리한 창고).
② ✕ 원저 논문은 **1차**.
③ ○ 여러 문헌을 수집·정리·평가해 **종합** → 3차 (Slide 44).
④ ✕ 교과서는 **3차**.
⑤ ✕ MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, 메드라인: NLM이 선별한 학술지의 서지 DB)은 서지정보 [즉, 제목·저자·저널·연도 같은 논문의 신상 정보] DB = **2차**.

🧠 한 줄 **종설 = 3차**

문제 22 EBP · 문헌 장단점 기출

1·2·3차 문헌의 특징으로 옳지 않은 것은?

① 1차 문헌은 가장 최신 정보이며 lag time이 가장 짧다.
② 1차 문헌은 저자의 실험만 반영되어 객관적이지 못할 수 있다.
③ 2차 문헌은 1차 문헌의 서지정보를 모아 1차 문헌으로의 직접 접근을 허용한다.
④ 3차 문헌은 lag time이 가장 짧아 최신 정보가 항상 실려 있다.
⑤ 2차 문헌은 사용법이 복잡하고 시스템 구축 비용이 비싸다.

✏️ 내 풀이

정답 ④ 3차 문헌은 lag time이 [즉, 정보가 생겨서 이용자에게 닿기까지 걸리는 시간] 가장 짧아 최신 정보가 항상 실려 있다.

🧭 **사고의 흐름**

💡 연결 lag time: 1차 < 2차 < 3차

☑️ **보기별 체크**

① ✗ 1차 장점 — 맞음.
② ✗ 1차 단점 — 맞음.
③ ✗ 2차 정의 — 맞음.
④ ○ 3차는 lag time이 **가장 길고** 최신 정보가 실리지 않는 경우가 많음.
⑤ ✗ 2차 단점 — 맞음.

🧠 한 줄 **3차 = 쉽지만 늦다**

문제 23 EBP · 국내 정보원

낱알만 남은 약의 이름을 확인하려 한다. 슬라이드에서 '의약품 식별 관련 정보량이 많고 정확하다'고 소개한 정보원은?

① 약학정보원
② 식약처 의약품안전나라
③ KIMS 의약품정보센터
④ 건강보험심사평가원
⑤ 한국희귀필수의약품센터

✏️ 내 풀이

정답 ① 약학정보원

🧭 **사고의 흐름**

💡 연결 허가는 식약처 · 식별은 약학정보원 · 대체는 KIMS · 보험은 심평원

☑️ **보기별 체크**

① ○ health.kr — 국내 제조/수입 의약품, **식별** 정보.
② ✗ 허가사항 [즉, 식약처가 허가한 효능·용법·주의사항]·안전성 서한 [즉, 새로 발견된 위험을 의료진에게 알리는 공문]·회수/폐기·행정처분.
③ ✗ 대체 가능 의약품·생산발매 현황.
④ ✗ 보험인정 기준·약제 기준·DUR (Drug Utilization Review, 의약품 안전사용 서비스: 처방·조제 때 병용금기 등을 실시간 점검).
⑤ ✗ 희귀·필수의약품 공급.

🧠 한 줄 **낱알 식별 = 약학정보원**

문제 24 EBP · 국외 정보원

UpToDate에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 학술지 원저 논문만 모아 둔 1차 문헌이다.
② 근거 기반·동료 심사를 거친 정보 자료로 웹과 모바일에서 쓸 수 있다.
③ NLM이 운영하는 무료 2차 문헌 DB이다.
④ Harrison's Online을 제공하는 전자 교과서이다.
⑤ 8,000명 이상의 저자가 쓰는 Medscape의 진료 현장 참고자료이다.

✏️ 내 풀이

정답 ② 근거 기반·동료 심사를 거친 정보 자료로 웹과 모바일에서 쓸 수 있다.

🧭 **사고의 흐름**

💡 연결 1차 근거의 요약 = UpToDate · Dynamed · eMedicine / 전자 교과서 = AccessMedicine

☑️ **보기별 체크**

① ✕ 1·2차를 종합한 **3차** 전문 DB (DataBase, 데이터베이스: 자료를 모아 검색할 수 있게 정리한 창고).
② ○ Slide 56 그대로.
③ ✕ 그건 **PubMed** (펍메드).
④ ✕ 그건 **AccessMedicine** (액세스메디슨).
⑤ ✕ 그건 **eMedicine** (이메디슨).

🧠 한 줄 **UpToDate** (업투데이트) **= 근거 기반 · 동료 심사**

문제 25 PubMed · PubMed 개요 기출

PubMed에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 미국 국립보건원(NIH)이 직접 운영하는 유료 데이터베이스이다.
② 1990년 이후의 영어 논문만 수록한다.
③ NLM 산하 NCBI가 운영하며, 수록 논문의 80% 이상은 MEDLINE 등재 학술지에서 온다.
④ 수록된 모든 논문의 원문을 무료로 제공한다.
⑤ MEDLINE이 PubMed를 포함하는 더 큰 데이터베이스이다.

✏️ 내 풀이

정답 ③ NLM (National Library of Medicine, 미국 국립의학도서관) **산하 NCBI** (National Center for Biotechnology Information, 미국 국립생물공학정보센터)**가 운영하며, 수록 논문의 80% 이상은 MEDLINE** (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, 메드라인: NLM이 선별한 학술지의 서지 DB) **등재 학술지에서 온다.**

🧭 **사고의 흐름**

💡 연결 NIH ⊃ NLM ⊃ NCBI → PubMed / PubMed = MEDLINE + PMC + 기타

☑️ **보기별 체크**

① ✕ NLM 산하 **NCBI**가 운영하는 **무료** DB.
② ✕ **1946년** 이후, **40개 언어**(영어 86%).
③ ○ Slide 4·6 그대로.
④ ✕ 서지·초록 DB — 원문은 링크·PMC (PubMed Central, 펍메드 센트럴: NIH가 운영하는 무료 원문 저장소)로 연결될 뿐.
⑤ ✕ **PubMed ⊃ MEDLINE**.

🧠 한 줄 **NCBI 운영 · 무료 · 2차 · MEDLINE 80%↑**

문제 26 PubMed · MeSH 기출

MeSH에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① MeSH 화면의 Entry Terms는 그 용어의 상위 개념 목록이다.
② PubMed 서지정보 색인에 쓰이는 NLM의 통제된 어휘 동의어집이다.
③ 상위/하위 개념을 16개 트리 구조로 분류한다.
④ 1년에 한 번 개정되며 신규 용어가 추가된다.
⑤ MeSH로 검색하면 기본적으로 하위 용어까지 함께 검색된다.

✏️ 내 풀이

정답 ① **MeSH** (Medical Subject Headings, 메쉬: 의학 주제 표목 — 논문 분류용 표준 주제어) **화면의 Entry Terms** (도입어) [즉, 같은 뜻의 다른 표현 목록]**는 그 용어의 상위 개념 목록이다.**

🧭 **사고의 흐름**

💡 연결 MeSH 화면: 정의 · 도입 연도 · Subheadings · Major Topic · noexp · Entry Terms(동의어) · 트리

☑️ **보기별 체크**

① ○ Entry Terms = **동의어·유의어** 목록 (자연어 검색에 활용).
② ✕ Slide 14 a — 맞음.
③ ✕ Slide 15 b — 맞음.
④ ✕ Slide 15 c — 맞음.
⑤ ✕ explode (확장 검색) [즉, 하위 용어까지 자동으로 포함] — 맞음.

🧠 한 줄 **Entry Terms = 동의어**

문제 27 PubMed · 자연어 vs MeSH 기출

자연어 검색과 MeSH 검색을 비교한 것으로 옳은 것은?

① 자연어 검색은 정확률(특이도)을 높이는 검색이다.
② MeSH는 저자가 논문에 쓴 키워드를 그대로 모은 것이다.
③ 자연어 검색은 동의어를 빠뜨리지 않는다.
④ PubMed는 MeSH와 자연어를 동시에 검색하지 않는다.
⑤ MeSH 검색은 새로운 개념이나 최신 논문을 누락할 수 있다.

✏️ 내 풀이

정답 ⑤ **MeSH 검색은 새로운 개념이나 최신 논문을 누락할 수 있다.**

🧭 **사고의 흐름**

💡 연결 자연어 = 많이(민감도) / MeSH = 정확히(특이도) → 실전은 MeSH OR 자연어

☑️ **보기별 체크**

① ✕ 자연어 = **재현율** [즉, 관련 논문을 빠뜨리지 않고 찾아내는 비율]**(민감도** [즉, 있는 것을 있다고 잡아내는 능력]**)** ↑.
② ✕ MeSH = 색인 [즉, 논문마다 주제 꼬리표를 붙여 찾기 쉽게 하는 일] 전문가가 **표준화**한 단어.
③ ✕ 동의어·모호한 개념 **누락**이 자연어의 단점.
④ ✕ 자동 매핑이 **MeSH OR 자연어**로 함께 검색.
⑤ ○ MeSH 단점 — 아직 용어가 없거나 색인 전인 논문.

🧠 한 줄 **자연어 민감 · MeSH 특이**

문제 28 PubMed · 자동 용어 매핑

검색창에 pharmacy student를 입력하였다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

① Author → Journal → MeSH 순서로 매핑된다.
② 두 단어 사이의 공백은 OR로 처리된다.
③ 변환된 검색식은 Advanced → Details에서 확인할 수 있다.
④ MeSH 검색만 이루어지고 All Fields 검색은 하지 않는다.
⑤ 큰따옴표로 감싸도 자동 매핑은 그대로 작동한다.

✏️ 내 풀이

정답 ③ **변환된 검색식은 Advanced** (고급 검색) **→ Details** (세부 내용)**에서 확인할 수 있다.**

🧭 **사고의 흐름**

💡 연결 "students, pharmacy"[MeSH Terms] OR ... [All Fields] — Details 화면에서 확인

☑️ **보기별 체크**

① ✕ **MeSH** (Medical Subject Headings, 메쉬: 의학 주제 표목 — 논문 분류용 표준 주제어) **→ Journal → Author** 순서.
② ✕ 공백 = **AND** (기본값).
③ ○ Slide 20 b · 🎙️ 교수님: 반드시 확인.
④ ✕ MeSH Terms **OR** All Fields.
⑤ ✕ 따옴표를 쓰면 자동 매핑이 **꺼짐**.

🧠 한 줄 **MeSH > Journal > Author, Details로 확인**

문제 29 PubMed · 필드 태그 기출

필드 태그를 사용한 검색식 중 형식이 옳지 <u>않은</u> 것은?

① aspirin[mh] OR aspirin[tiab]
② aspirin[ti] AND 2015:2020[dp]
③ statin*[tiab] NOT letter[pt]
④ diabetes[majr]
⑤ (aspirin OR ibuprofen)[ti]

✏️ 내 풀이

정답 ⑤ **(aspirin OR ibuprofen)[ti]**

🧭 **사고의 흐름**

🔍 함정 체크 Slide 27 예4: (caffeine OR coffee)[ti] (X) · 🎙️ "필드 태그는 단어마다"

☑️ **보기별 체크**

① ✕ MeSH + 제목·초록 — 옳은 형식.
② ✕ 제목 + 출판 기간 — 옳은 형식.
③ ✕ 출판 유형이 편지인 것 제외 — 옳은 형식.
④ ✕ 주요 주제 — 옳은 형식.
⑤ ○ 태그는 **검색어마다** — aspirin[ti] OR ibuprofen[ti]로 써야 함.

🧠 한 줄 **괄호에 태그 한 번 = ✕**

문제 30 PubMed · 검색 기술 구별 기출

검색 기술에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 인접검색에서 N이 커질수록 검색 결과 수는 줄어든다.
② 어구검색(" ")을 하면 검색 결과 수가 늘어난다.
③ "drug interaction"[tiab:~3]은 두 단어 사이에 3개 이하의 단어가 있어도 검색하며, 단어 순서는 상관없다.
④ 절단검색(*)은 * 앞에 최소 2글자만 있으면 된다.
⑤ 괄호가 없으면 오른쪽에서 왼쪽으로 계산된다.

✏️ 내 풀이

정답 ③ "drug interaction"[tiab:~3]은 두 단어 사이에 3개 이하의 단어가 있어도 검색하며, 단어 순서는 상관없다.

🧭 **사고의 흐름**

💡 연결 " " ↓ · * ↑ · ~N은 N ↑일수록 ↑ · ( ) 먼저, 없으면 왼→오

☑️ **보기별 체크**

① ✕ N ↑ → 허용 범위 ↑ → 결과 ↑ (642 → 896).
② ✕ 붙은 어구만 → 결과 ↓ (11,969 → 5,941).
③ ○ Proximity 특징 그대로 (Slide 29).
④ ✕ 최소 **4글자**.
⑤ ✕ **왼쪽 → 오른쪽**.

🧠 한 줄 **인접 = 가까우면 OK, 순서 무관**

문제 31 EBP · Sackett 정의 기출

다음은 Sackett의 EBM 정의이다. 빈칸에 알맞은 말을 쓰시오.

" ① 근거를 ② 환자의 진료에 대한 ③ 을(를) 내리는 데 성실하고, 명시적이며, 신중하게 사용하는 것"

✏️ 내 풀이

정답 ① current best (최선의 최신) ② individual (개별) ③ decisions (결정)

📏 **채점 기준**

세 칸 모두 맞아야 만점. 영어·한글 모두 인정.

🔍 **자주 틀리는 답**

✕ best만 쓰기(current 누락) · patients만 쓰기(individual 누락) · evidence를 칸에 쓰기

문제 32 EBP · 근거 피라미드 기출

근거 수준 피라미드의 빈칸에 알맞은 말을 쓰시오.

1층 체계적 문헌고찰 → 2층 ① → 3층 ② → 4층 RCT → 5층 코호트 연구 → 6층 환자-대조군 연구·증례 보고 → 7층 기본 배경 정보 / 전문가 의견

1–3층은 ③ 정보이다.

✏️ 내 풀이

정답 ① 비평적 [즉, 장단점을 따져 믿을 만한지 평가하는] **분석 주제 (Critically-Appraised Topics, CAT** (Critically-Appraised Topic, 비평적 분석 주제: 한 질문에 대한 여러 연구의 평가 요약)**) ② 개별 문헌에 대한 비평적 분석 (Critically-Appraised Individual Articles) ③ 여과된 (filtered)**

📏 **채점 기준**

①②는 영어·한글 중 하나, ③은 여과된/filtered.

🔍 **자주 틀리는 답**

✕ ①②를 서로 바꿔 쓰기 · ③에 '여과되지 않은' 쓰기

문제 33 PubMed · PubMed 운영 기출

빈칸에 알맞은 말을 쓰시오.

PubMed는 미국 국립의학도서관 ① _____ 산하 ② _____ 가 운영하는 무료 데이터베이스이며, 수록 논문의 80% 이상은 ③ _____ 등재 학술지에서 온다.

✏️ 내 풀이

정답 ① NLM (National Library of Medicine) ② NCBI (National Center for Biotechnology Information) ③ MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, 메드라인: NLM이 선별한 학술지의 서지 DB)

📏 **채점 기준**

약어 또는 풀네임 모두 인정.

🔍 **자주 틀리는 답**

✕ ②에 NIH (NLM의 상위 기관) · ③에 PMC (무료 원문 아카이브, 일부)

문제 34 PubMed · 인접검색 검색식

제목(title)에 pharmacy와 education이 두 단어 사이에 2개 이하의 단어를 두고(순서 무관) 나타나는 논문을 찾는 검색식을 쓰시오.

검색식: ① _____

✏️ 내 풀이

정답 ① "pharmacy education"[ti:~2] (또는 [title:~2])

📏 **채점 기준**

큰따옴표 + [ti:~2] 형식이면 정답.

🔍 **자주 틀리는 답**

✕ pharmacy education[ti] (인접 조건 없음) · "pharmacy education"[ti] (어구검색 — 붙은 것만) · pharmac*

문제 35 EBP · 1·2·3차 문헌 기출

다음에 해당하는 문헌의 종류를 쓰시오.

(1) lag time이 가장 긴 문헌: ① _____

(2) 1차 문헌의 서지정보를 모아 데이터베이스로 정리한 문헌과 그 대표 예 1가지:

② _____

✏️ 내 풀이

정답 ① 3차 문헌 ② 2차 문헌 — PubMed (또는 MEDLINE, EMBASE (Excerpta Medica Database, 엠베이스: 유럽 중심의 의약학 서지 DB))

📏 **채점 기준**

②는 종류와 예가 모두 맞아야 정답.

🔍 **자주 틀리는 답**

✕ ①에 1차 (lag time 가장 짧음) · ②의 예로 UpToDate (3차)

문제 36 EBP · EBM 5단계

EBM 5단계 중 근거의 타당성(validity)과 적용가능성(applicability)을 비판적으로 평가하는 단계와, 그 바로 앞 단계의 이름을 영어로 쓰시오.

평가 단계: ① _____ · 바로 앞 단계: ② _____

✏️ 내 풀이

정답 ① **Appraise** (비판적 평가) ② **Acquire** (근거 찾기)

📏 **채점 기준**

철자가 맞아야 정답.

🔍 **자주 틀리는 답**

✕ ①에 Apply (적용 단계) · ②에 Ask (Acquire 앞 단계)

문제 37 EBP · EBM 5단계 기출

EBM 5단계를 순서대로 쓰고, 각 단계에서 하는 일을 한 문장씩 설명하시오.

✏️ 내 풀이

모범답안

① **Ask** (질문하다): 환자 문제에 대해 명확·간결·임상적인(3C) 질문을 PICO (Patient·Intervention·Comparison·Outcome, 환자·중재·비교·결과: 임상 질문을 만드는 4요소)로 만든다. ② **Acquire**: 질문에 답할 최선의 근거를 문헌(1·2·3차, PubMed (펍메드))에서 찾는다. ③ **Appraise**: 찾은 근거의 **타당성**과 **적용가능성**을 비판적으로 평가한다. ④ **Apply** (적용): 평가 결과를 **임상 전문성·환자 정보(가치)**와 통합해 적용한다. ⑤ **Evaluate** (평가·개선): 1–4단계 수행의 **효과성과 효율성**을 평가해 다음번에 개선한다.

🔑 **핵심어 (빠지면 감점)**

`Ask · 3C · PICO` `Acquire · 문헌 검색` `Appraise · 타당성·적용가능성` `Apply · 전문성+환자` `Evaluate · 효과성·효율성`

📏 **채점 기준**

단계 이름·순서 2점 + 각 단계 설명 2점. 순서가 틀리면 이름 점수 0.

문제 38 EBP · PICO 질문 만들기 기출

다음 사례를 PICO로 나누고, 한 문장의 임상 질문으로 쓰시오.

비판막성 심방세동으로 와파린을 복용 중인 75세 여성이, 아픽사반으로 바꾸면 출혈 위험이 줄어드는지 묻는다.

✏️ 내 풀이

모범답안

P: 와파린을 복용 중인 비판막성 심방세동 75세 여성 · **I**: 아픽사반으로 변경 · **C**: 와파린 유지 · **O**: 주요 출혈 발생 감소.
질문: "와파린을 복용 중인 75세 비판막성 심방세동 여성(P)에서 아픽사반으로 바꾸는 것(I)이 와파린을 유지하는 것(C)에 비해 주요 출혈을 줄이는가(O)?"

🔑 **핵심어 (빠지면 감점)**

`P 환자·질환·나이` `I 새 중재(아픽사반)` `C 비교(와파린)` `O 측정 가능한 결과(출혈)` `한 문장 질문`

📏 **채점 기준**

P·I·C·O 각 0.5점 + 완성된 질문 문장 2점. I와 C가 바뀌면 1점 감점.

문제 39 EBP · 피라미드 2층·3층 기출

근거 피라미드의 2층과 3층을 각각 설명하고, 여과된 정보와 여과되지 않은 정보의 차이를 쓰시오.

✏️ 내 풀이

모범답안

2층 **비평적** [즉, 장단점을 따져 믿을 만한지 평가하는] **분석 주제(CAT)**는 하나의 임상 질문(주제)에 대해 **여러 연구**를 전문가가 비평적으로 평가하고 짧게 종합한 요약이다. 3층 **개별 문헌에 대한 비평적 분석**은 **연구 논문 한 편**을 전문가가 평가해 요약·논평한 것이다. 1–3층(체계적 문헌고찰·CAT·개별 문헌 비평)은 누군가 이미 질을 평가·종합한 **여과된 정보**라 바로 활용할 수 있고, 4–6층(RCT·코호트·환자-대조군·증례)은 원 연구인 **여과되지 않은 정보**라 사용자가 직접 평가해야 한다.

🔑 **핵심어 (빠지면 감점)**

2층 CAT · 주제 · 여러 연구 종합 | 3층 · 논문 1편 평가 | 여과 = 이미 평가·종합 | 비여과 = 원 연구 · 직접 평가

📏 **채점 기준**

2층 1점 + 3층 1점 + 여과/비여과 구분 2점.

문제 40 PubMed · 자연어 vs MeSH 기출

자연어 검색과 MeSH 검색의 장단점을 비교하고, 실제 검색에서 둘을 어떻게 함께 쓰는지 예를 들어 쓰시오.

✏️ 내 풀이

모범답안

자연어 검색은 제목·초록·저자 키워드의 단어로 찾아 새로운 개념도 표현할 수 있어 **재현율** [즉, 관련 논문을 빠뜨리지 않고 찾아내는 비율]**(민감도** [즉, 있는 것을 있다고 잡아내는 능력]**)**이 높지만, 동의어·모호한 개념을 누락하고 부적절한 논문이 섞인다. **MeSH** (Medical Subject Headings, 메쉬: 의학 주제 표목 — 논문 분류용 표준 주제어) **검색**은 색인 [즉, 논문마다 주제 꼬리표를 붙여 찾기 쉽게 하는 일] 전문가가 표준화한 단어로 찾아 일관되고 정확해 **정확률** [즉, 찾은 논문 중 진짜 관련 있는 논문의 비율] **(특이도** [즉, 없는 것을 없다고 걸러내는 능력]**)**이 높지만, 새로운 개념이나 색인 전 최신 논문을 누락한다. 따라서 개념마다 **MeSH OR 자연어**로 묶어 쓴다. 예: caffeine[mh] OR caffein*[tiab].

🔑 **핵심어 (빠지면 감점)**

자연어 = 재현율(민감도)↑ | 자연어 단점 = 동의어 누락 | MeSH = 정확률(특이도)↑ | MeSH 단점 = 새 개념·최신 논문 누락 | MeSH OR 자연어 예

📏 **채점 기준**

장단점 각 0.5점(4개) + 결합 방법과 예 2점. 민감도·특이도를 반대로 쓰면 해당 부분 0점.